

Decisión Alfa / Beta / Gamma / Delta

Prefacio (léeme primero)

Para quién: tú, cuando quieres **aprender con hasta 10 farmacias** antes de cobrar fuerte o antes de que entre el capital del inversor.

No es para: cerrar el SAFE ni vender cupos Semilla/Fundadora a ciegas (ver CrowdPharma).

En una frase de calle: “Primero prueban la app (Alfa); las que sí usan firman contrato con 2 meses de cuota fija en cero (Beta). Lo raro (Gamma) no se hace.”

Antes de seguir: [GLOSARIO](#) · [Comparativa](#) · [Qué hacer ahora](#)

Estado: [PROPUESTA OPERATIVA – NO AUTORIZA CONTACTO]

Versión: 1.1 — 27 agosto 2026 (paridad playbook: controles + KPI + FAQ + checklist)

Para qué sirve: menú del experimento Café + Kleo y cuál elegir / cómo ejecutarlo.

No es: forense de videos (eso está en [evidencia/](#)).

Canon intacto: ask SAFE **USD 237.412** (no recaudado) · cap **USD 1.582.747** · equity ref. **~15%** · pricing **45/60/70 + 8/7/5% GMV**.

Sin contacto hasta CAP-P09 + OK explícito.

Evidencia: [EXT_CAFE.md](#) · [EXT_KLEO.md](#)

Decisión recomendada: Alfa ahora → Beta después del uso. Delta = hipótesis post-cobro. Gamma cerrado.

Playbook comercial (cupos): [PLAN_CROWDPHARMA.md](#) — no reemplaza esta matriz.

Capital: [PLAN_SAFE_GABRIEL.md](#) — instrumento aparte.

Vista rápida

Plan	¿Elegible ahora?	Qué es
Alfa	Sí	Hasta 10 prueban la app (pre-wire)
Beta	Después del uso	S1: contrato + waiver, máx. 10
Gamma	No	Lifetime / cap 800k / exclusividad / sprint 4 semanas
Delta	No	S2 prepago anual tras cobro real

Tres controles críticos (blindaje)

#	Riesgo	Control
1	Alfa confundido con cobro o equity	Alfa = aprendizaje de producto. No depósito Semilla, no waiver, no SAFE. Probar ≠ WTP.
2	Beta prematuro	Beta solo tras uso real (catálogo + pedido) y CAP-P01 cerrado (%GMV sin ambigüedad). Si falta → seguir en Alfa o solo discovery.
3	Roles mezclados (farmacia también “quiere invertir”)	Misma persona = dos instrumentos . Prueba/contrato → este método o CrowdPharma. Capital → SAFE. Nunca “prueba gratis → socio del SAFE”.

Plan Alfa — prueba de producto pre-wire

Encaje: fases 1–2 de Kleo + membresía de consumo del caso Café + las 10 farmacias como **prueba de app**, no como contrato ni waiver.

Pasos

1. Ejecutar ≥5 mom-test reales antes de publicar contenido de «problemas de farmacia».
2. Usar una CTA inbound: «evaluación / prueba de la app», con formulario fuera de Flutter/Laravel.
3. Cualificar decisor, sede Valencia, catálogo y farmacéutico antes de contar un lead.
4. Permitir que hasta 10 farmacias prueben catálogo, flujo Rx y pedido controlado.
5. Registrar incidencias por farmacia y no ampliar mientras se repitan fallos críticos.
6. Convertir a Beta solo las que usen de verdad; probar no demuestra WTP.
7. Usar evidencia E3–E5 en carril A; no usar un formulario público de ronda.
8. Probar un `delivery_company` con SLA no exclusivo.

Criterios de parada

- el formulario atrae pacientes/curiosos, no decisores B2B;
- el abandono del formulario exige simplificarlo;
- el contenido genera atención pero cero interés cualificado;
- los **mismos fallos críticos** (catálogo, Rx, pedidos) se repiten en **>2 farmacias** sin fix de fondo;
- no hay `CAP-P09` + **OK founder** para outreach outbound o scripts;
- el producto todavía no puede incorporar una farmacia con seguridad.

Código: ninguno. `SubscriberController` es una lista de email web/paciente y no se amplía para este flujo.

Plan Beta — Fundadoras S1 después del uso

Encaje: fases 3–4 recortadas de Kleo + cohorte Café limitada por capacidad, sin retorno. En CrowdPharma = paquete **Fundadora**.

Pasos

1. Un subconjunto de Alfa que ya usó la app firma contrato marco.
2. Aplicar el waiver canónico: cuota fija USD 0 durante meses 1–2, máximo 10; `%GMV` sujeto a `CAP-P01`.
3. Ofrecer white-glove acotado: visitas, capacitación, minutas y canal de feedback; no soporte 24/7.
4. Medir catálogo activo, primera orden, GMV, soporte, conversión a pago y retención.
5. No ampliar S1 por encima de 10; la expansión hacia ~28 pertenece al reloj post-wire.
6. Mantener S2/lifetime fuera. Si una farmacia invierte, firma un SAFE separado.

Criterios de parada

- no comunicar el waiver mientras `%GMV` siga ambiguo (`CAP-P01` abierto);
- onboarding no repetible;
- presentar S1 como capital levantado;
- usar FOMO como «quedan tres cupos»;
- prometer lock indefinido, analytics inexistente o posicionamiento preferente;
- sin `CAP-P09` (o sin plantilla contractual `CAP-P05`) si el outreach es outbound de venta.

Detalle S1: [03_ESCENARIOS_S0_S1_S2.md](#).

Puente Alfa → Semilla vs Beta / Fundadora

Tras uso real en Alfa, elige **un** camino comercial (no ambos en el mismo pitch):

Situación	Siguiente paso	Dónde
Quiere compromiso económico acotado antes de waiver S1	CrowdPharma Semilla (fee/depósito con promesa entregable)	PLAN_CROWDPHARMA
Ya usó de verdad y acepta contrato + waiver 0x2	Beta = CrowdPharma Fundadora	Este plan + CrowdPharma \$5.1
Quiere poner capital	SAFE (otra reunión)	PLAN_SAFE_GABRIEL

Plan Gamma — control negativo, no elegir

Propuesta	Por qué se rechaza
USD 45 de por vida	Lock indefinido; contradice waiver 0x2
Segunda cohorte a USD 60 por «subida»	60 ya es Pro; un video no cambia el menú
Rolling SAFE cap 1.582.747→800k	Otro instrumento; el ask vigente no está recaudado
Exclusividad logística	Viola guardrail del piloto
10 firmas = fondear SAFE	Cliente ≠inversor; T+0 exige wire
Posts/DM automáticos en cuatro semanas	Viola regla de no contacto automático
White-glove 24/7	No existe capacidad financiada

Un «sí» genérico no rehabilita Gamma. Cualquier outreach requiere un plan nuevo, pipeline real (CAP-P06) y OK explícito (CAP-P09).

Plan Delta — S2 prepago anual futuro

Delta es el escenario S2: membresía de consumo cobrada por adelantado y asignada a servicios reales. **No es opción ahora.**

Solo se reabre después de Beta cuando existan: uso real, ciclo post-waiver cobrado, margen observado, política de refund, contador, abogado y reproyección founder. No diluye el cap SAFE ni convierte clientes en inversionistas.

Matriz de elección

Criterio	Alfa	Beta	Gamma	Delta
Encaje con canon	Alto	Alto si cierra CAP-P01	Nulo	Alto después de gates
Encaje con «10 prueban»	Alto	Es contrato, no prueba	Mezcla SAFE	Nulo ahora
Prueba WTP	No	Parcial: waiver ≠cobro	No	Sí, con cobro
Exige wire	No	No para las 10 S1	Finge T+0	No
Riesgo legal	Bajo si inbound	Medio por copy contractual	Alto	Alto sin asesoría

Criterio	Alfa	Beta	Gamma	Delta
Código app	No	No	No	No
¿Elegible ahora?	Sí	Después de uso	No	No

(diagrama omitido en PDF)

KPI semanales del experimento (ASSUMPTION)

Metas de **aprendizaje**, no de raise. Dashboard: [05_CALENDARIO_Y_DASHBOARD.md](#) . Números de meta = ASSUMPTION hasta cohorte **FACT** .

Indicador	Qué cuenta	Señal de salud
Mom-tests documentados	≥5 antes de contenido outbound	Sin esto → no Alfa masivo
Leads cualificados	Decisor + Valencia + catálogo + farmacéutico	Formulario no es waitlist paciente
Farmacias en Alfa	Cupos 1–10 activos en prueba	Capacidad de soporte
Incidencias críticas abiertas	Fallos catálogo/Rx/pedido sin fix	Si >2 farmacias mismo fallo → parada
Conversión a Beta	Subconjunto con uso real + contrato	Probar ≠WTP
E4 (primera orden real)	Pedido medible	Evidencia para carril A / CrowdPharma

FAQ corto

¿Esto es inversión?

No. Alfa es prueba de app; Beta es contrato de servicio con waiver. Capital = SAFE en otra conversación.

¿Por qué gratis / cuota 0?

Alfa no cobra. Beta: waiver **USD 0** meses 1–2 (máx. 10) para aprender con uso real; %GMV = CAP-P01 . No es lifetime.

¿Cuándo cobro Semilla vs cuándo Beta?

Semilla = compromiso acotado vía CrowdPharma sin exigir waiver S1. Beta/Fundadora = post-uso + contrato + waiver. Un camino por pitch.

¿Por qué solo 10?

Capacidad de onboarding white-glove / soporte, no FOMO de marketing.

¿Qué mide el éxito de Alfa?

Onboarding repetible + uso (idealmente E4) + log de incidencias cerrado — **no** “firmamos 10” ni “ya recaudamos”.

¿Por qué no Gamma?

Lifetime, exclusividad, SAFE por firmas de farmacia y sprints de DM automático rompen canon y CAP-P09 .

Calendario corto pre-wire (condicionado a CAP-P09)

Ventana	Acciones	No hacer
Días 1–14	≥5 mom-test; demo usable; formulario inbound; ficha “prueba app”	Outreach masivo; vender Semilla/Fundadora a ciegas
Días 15–45	Hasta 10 en Alfa; log de incidencias; 0–N Semilla solo si hay entrega (CrowdPharma)	Gamma; formulario de ronda SAFE; Beta sin uso
Tras uso real	Decidir Semilla o Beta/Fundadora; armar E3–E5	Mezclar cupo + SAFE en la misma hoja

Checklist del founder (imprimible)

Antes

- ☐ CAP–P09 autorizado (o solo materiales, sin contacto).
- ☐ Demo OK + ≥5 mom-test.
- ☐ Controles críticos verificados (Alfa ≠cobro/equity; Beta post-uso + CAP–P01 ; SAFE aparte).
- ☐ Formulario inbound = prueba/evaluación B2B (no waitlist paciente).
- ☐ Cupos Alfa 1–10 en hoja.

Cada semana (KPI)

- ☐ Leads cualificados / # en Alfa / incidencias / ¿parada?
- ☐ ¿Alguna conversión a Beta o Semilla justificada?
- ☐ Copy: ¿se filtró “inversión / retorno / socios”? Corregir.

Puente a otros métodos

- ☐ CrowdPharma solo con promesa entregable (CAP–P05 si hay cobro).
- ☐ SAFE solo con evidencia E3+ y reunión separada.

Ver también

- Qué hacer ahora: [00_QUE_HACER_AHORA.md](#)
- CrowdPharma (Semilla/Fundadora): [PLAN_CROWDPHARMA.md](#)
- SAFE (capital): [PLAN_SAFE_GABRIEL.md](#)
- S0/S1/S2: [03_ESCENARIOS_S0_S1_S2.md](#)
- Evidencia videos: [evidencia/](#)
- Decisiones (CAP–P09): [06_DECISIONES_ABIERTAS.md](#)